

TEMA 9.62 • RESPIRATORIO

Rinitis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.006
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Rinitis

La rinitis se define como la inflamación de la mucosa nasal. Clínicamente, se manifiesta por un conjunto de síntomas característicos que afectan la calidad de vida del paciente.

- La tríada clínica clásica de la rinitis incluye:
- **Rinorrea** (hialina o purulenta según la causa).
- **Estornudos** (frecuentemente en salva en casos alérgicos).
- **Obstrucción nasal** (congestión).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La obstrucción nasal en la rinitis se produce por la vasodilatación de los plexos venosos de los cornetes y el edema de la mucosa, lo cual reduce el flujo de aire. La inflamación crónica puede llevar a una hipervascularización, facilitando complicaciones como la epistaxis.

Complicaciones de la Rinitis

Una rinitis no controlada, especialmente cuando predomina la obstrucción, puede derivar en diversas complicaciones:

- **Roncopatía:** La obstrucción nasal crónica altera el flujo de aire durante el sueño, favoreciendo el ronquido.
- **Epistaxis:** La inflamación hace que la mucosa esté más frágil y los vasos sanguíneos sean más superficiales y fáciles de romper.
- **Infecciones de repetición:** La obstrucción genera retención de secreciones, lo que facilita la sobreinfección bacteriana.
- - **Otitis Media Aguda** (por disfunción de la trompa de Eustaquio).
- - **Rinosinusitis Aguda** recurrente.

Clasificación Principal

Las rinitis se subdividen a grandes rasgos en dos grupos:

1. Rinitis Alérgica

Es la causa más frecuente. Se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo I mediada por IgE ante la exposición a un alérgeno. - **Estacional:** Generalmente asociada al polen. El diagnóstico suele ser evidente por la temporalidad. - **Perenne:** Los síntomas persisten durante todo el año. Se asocia a alérgenos intradomiciliarios como ácaros del polvo, epitelio de animales (gatos/perros) u hongos.

2. Rinitis No Alérgica

Suelen ser de inicio más tardío y no presentan el componente inmunológico clásico. - **Rinitis Vasomotora:** Es la más preguntada. Se produce por una hiperreactividad de la mucosa ante estímulos inespecíficos (cambios de temperatura, olores fuertes). - **Rinitis Gustatoria:** Similar a la vasomotora, desencadenada por alimentos (especialmente calientes o muy condimentados). - **Rinitis Hormonal:** Típica del embarazo debido a los cambios en los niveles de estrógenos. - **Rinitis Atrófica (Ozena):** Caracterizada por la atrofia de la mucosa y formación de costras fétidas.

Diferencias entre Rinitis Alérgica y No Alérgica

TABLA 9.62.1: CARACTERÍSTICA VS RINITIS ALÉRGICA		
CARACTERÍSTICA	RINITIS ALÉRGICA	RINITIS NO ALÉRGICA
Edad de inicio	Niñez o adolescencia (temprano)	Adultos (tardío)
Prurito (picazón)	Muy frecuente (nariz y ojos)	Habitualmente ausente
Estacionalidad	Puede ser estacional o perenne	Perenne o recurrente
Desencadenantes	Alérgenos (polen, polvo, caspa)	Cambios de temperatura, comida, fármacos
Aspecto de la mucosa	Pálida y edematosa	Roja e hiperémica
Asociaciones	Asma, Dermatitis Atópica, conjuntivitis	No suele asociar atopía

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si el paciente presenta **prurito nasal u ocular**, piensa inmediatamente en causa **alérgica**. Si los síntomas aparecen al comer algo caliente o cambiar de ambiente (**frío/calor**), piensa en **rinitis vasomotora**.

Examen Físico y Estigmas de Atopía

En la rinitis alérgica, es común encontrar signos físicos que orientan al diagnóstico:

- **Pliegues de Dennie-Morgan:** Doble pliegue o línea infraorbitaria (ojeras marcadas) secundario al edema crónico.
- **Ojeras alérgicas:** Coloración violácea o morada debajo de los ojos por congestión venosa local.
- **Pliegue nasal transversal:** Una línea horizontal en el puente de la nariz causada por el "saludo alérgico" (el acto frecuente de frotarse la nariz hacia arriba debido al prurito).
- **Mucosa nasal:** Al realizar la rinoscopia simple, se observa una mucosa de aspecto pálido, azulado o grisáceo, con cornetes aumentados de tamaño.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es importante recordar que las rinitis pueden ser **mixtas**. Un paciente con rinitis alérgica de base puede presentar también componentes de rinitis vasomotora ante cambios de temperatura.

Resumen de Variantes No Alérgicas Específicas

- **Rinitis Vasomotora:** La mucosa reacciona de forma exagerada ante estímulos físicos. No hay alérgenos involucrados.
- **Rinitis Hormonal:** Frecuente en el segundo y tercer trimestre del embarazo; suele resolverse tras el parto.
- **Rinitis Medicamentosa:** (Mencionada indirectamente como desencadenante) Ocurre por el uso excesivo de descongestionantes tópicos (vasoconstrictores como la oximetazolina), generando un efecto rebote.

NOTA CLÍNICA

El manejo específico de la rinitis alérgica (antihistamínicos, corticoides intranasales) se abordará en profundidad en el siguiente módulo de tratamiento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un niño de 8 años consulta por rinorrea acuosa, estornudos frecuentes y prurito nasal intenso desde los 5 años. Los síntomas empeoran en primavera. Al examen se observan ojeras marcadas, un pliegue nasal transversal y mucosa nasal pálida y edematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Rinitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clínica principal de rinitis: rinorrea, estornudos y obstrucción nasal
- Complicaciones: rinosinusitis, epistaxis, otitis media aguda, rinosinusitis por retención de secreciones
- Rinitis alérgica es la causa más frecuente; puede ser estacional (polen) o perenne
- La rinitis alérgica se asocia a prurito nasal/ocular, conjuntivitis alérgica y estigmas de atopia
- Signos de atopia: pliegue de Dennie-Morgan, ojeras, asma, urticaria, dermatitis atópica
- Mucosa nasal pálida y edematosa en alérgica vs roja e hiperémica en no alérgica
- La rinitis no alérgica cursa sin prurito, con inicio tardío y desencadenantes como cambios de temperatura
- Pueden coexistir rinitis alérgica y no alérgica (formas mixtas)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RINITIS)**PREGUNTA 1**

Un niño de 8 años consulta por rinorrea acuosa, estornudos frecuentes y prurito nasal intenso desde los 5 años. Los síntomas empeoran en primavera. Al examen se observan ojeras marcadas, un pliegue nasal transversal y mucosa nasal pálida y edematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Rinitis vasomotora
- B)** Rinitis alérgica estacional
- C)** Rinitis atrofica
- D)** Rinitis gustatoria
- E)** Rinitis hormonal

PREGUNTA 2

Una paciente de 45 años consulta por obstrucción nasal y rinorrea que aparece principalmente con los cambios de temperatura y al exponerse a olores fuertes. No refiere prurito nasal ni ocular. Niega antecedentes de atopia. Al examen se observa mucosa nasal eritematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Rinitis alérgica perenne
- B)** Sinusitis crónica
- C)** Rinitis vasomotora
- D)** Rinitis farmacológica
- E)** Poliposis nasal

PREGUNTA 3

Respecto a las complicaciones de la rinitis crónica, ¿cuál de los siguientes mecanismos explica mejor la asociación entre rinitis y otitis media aguda?

- A)** Diseminación hematogénica de la infección desde la mucosa nasal al oído medio
- B)** La obstrucción nasal genera retención de secreciones que favorece infecciones, incluyendo la vía de la trompa de Eustaquio
- C)** El prurito nasal produce traumatismo repetido que lesiona la membrana timpánica
- D)** La rinorrea posterior irrita directamente la membrana timpánica
- E)** La epistaxis recurrente produce anemia que predispone a infecciones otíicas

RESUMEN: RINITIS

Esta clase presenta las generalidades de la rinitis, una patología muy frecuente cuya clínica principal incluye rinorrea, estornudos y obstrucción nasal. Las complicaciones más importantes son la rinosinusitis (por obstrucción), la epistaxis (por inflamación y fragilidad vascular), y las infecciones asociadas a retención de secreciones como otitis media aguda y rinosinusitis aguda. Las rinitis se clasifican en alérgicas (la causa más frecuente) y no alérgicas. La rinitis alérgica puede ser estacional (típicamente por polen, confirma causa alérgica) o perenne (constante durante el año, puede confundirse con no alérgica). Las no alérgicas incluyen la vasomotora, la gustatoria, la hormonal (embarazo) y la atrofica u ósea. Para diferenciar entre alérgica y no alérgica, existen claves clínicas importantes: la alérgica se asocia a prurito nasal y ocular, conjuntivitis alérgica, antecedentes de atopia (asma, urticaria, dermatitis atópica), inicio en la infancia/adolescencia, desencadenamiento por alérgenos específicos, pliegue de Dennie-Morgan, ojeras y mucosa nasal pálida y edematosa. La no alérgica se presenta sin prurito, con inicio tardío, desencadenantes como cambios de temperatura o alimentos condimentados, síntomas perennes pero no estacionales, y mucosa nasal roja e hiperémica. Pueden coexistir ambas (mixtas).